

ITEM 269 : ULCERE GASTRODUODENAL et GASTRITE

ULCERE GASTRO-DUODENAL

Ulcère = perte de substance de la paroi gastrique ou duodénale atteignant en profondeur la **muscleuse**

- Incidence = 90 000/an en France (en ↘), 10% de mortalité en cas de complication, plus fréquent au niveau duodénal < 55 ans
- Prédominance masculine (2/1) pour l'ulcère duodénal et sex ratio = 1 pour l'ulcère gastrique
- **Ulcère chronique** : socle scléro-inflammatoire contenant des hyperplasies nerveuses et des lésions d'endartérite
- A différencier de l'**érosion** (atteinte limitée à la muqueuse) ou de l'**ulcération** (atteinte limitée à la sous-muqueuse)

- **Barrière muqueuse** (stimulé par les prostaglandines) : **pré-épithéliale** (mucus, bicarbonate, phospholipides), **épithéliale** (cellules de surface), et **sous-épithéliale** (flux sanguin muqueux)
- Ulcère gastrique = surtout par altération des défenses : **AINS, atrophie glandulaire, tabac, pan-gastrite à *H. pylori***
- Ulcère duodénal = surtout lié à des situations d'hypersécrétion acide : **AINS, gastrite antrale à *H. pylori*...**

Physiopathologie	Ulcère à <i>Helicobacter pylori</i>	<i>H. pylori</i> : BGN, résistante à l'acidité gastrique grâce à son activité uréasique, principalement antrale - Infection le plus souvent dans l' enfance par voie oro-orale ou féco-orale - Touche la majorité des individus des pays en voie de développement, en ↘ dans les pays développés - Conséquence : gastrite aiguë , évoluant vers la gastrite chronique dans la majorité des cas - Complication : - Aucune dans la majorité des cas - Ulcère gastroduodénal - Cancer : ADK ou lymphome
	Ulcère aux AINS	- Activité anti-COX1 → ↘ prostaglandine → altère les défenses : ulcère , le plus souvent gastrique - AINS sélectifs (coxibs) : ↘ le risque d'ulcère compliqué de 50% sans le supprimer - Aspirine à dose antiagrégante : potentiel ulcérogène , augmente le risque hémorragique
	Ulcère non lié à <i>Helicobacter</i> ou aux AINS (20%)	- Syndrome de Zollinger-Ellison (rare) : hypersécrétion acide par sécrétion de gastrine (gastrinome) - Autres causes : tabac, terrain génétique, vascularite (→ l'alcool et le café ne sont pas des FdR) - Terrain à risque : comorbidités , notamment cardiovasculaires, rénales, hépatiques ou pancréatique

Diagnostic	C	Syndrome ulcéreux typique		- Douleur épigastrique : sans irradiation, à type de crampe ou faim douloureuse, calmée par la prise d'aliments ou d'antiacide, rythmée par les repas avec intervalle libre de 1 à 3h - Evolution spontanée par poussées de quelques semaines, séparées de périodes asymptomatiques de quelques mois/années → évocatrice d'un ulcère à <i>H. pylori</i>
		Syndrome ulcéreux atypique		= Plus fréquent : siège sous-costal droit ou gauche ou strictement postérieur , hyperalgie pseudo-chirurgical ou fruste (simple gêne), non rythmée par l'alimentation
		Complication		= Parfois inaugurale : hémorragie, perforation, sténose
	PC	Endoscopie digestive haute	= Visualisation du tractus digestif jusqu'au 2 ^{ème} duodénum + biopsies - Ulcère = perte de substance creusante, de forme généralement ronde/ovale, à fond pseudo-membraneux (blanchâtre), parfois nécrotique (noir), à bords réguliers, surélevés et érythémateux - Ulcère gastrique : généralement de l'antré ou de la petite courbure, à risque de cancer → Biopsie des berges systématique (6 à 12 selon la taille) - Ulcère duodénal : en plein bulbe ou à la pointe du bulbe, sans risque de cancer (biopsie inutile) → Localisation post-bulbaire (très rare) : évocateur de Zollinger-Ellison, Crohn ou vascularite - Biopsies de l'antré et du fundus systématique : recherche de <i>H. pylori</i> , degré de gastrite	
		Recherche de <i>H. pylori</i>	Test sur biopsie gastrique	- Examen histologique des biopsies antrales et fundiques = référence : coloration cresyl violet ou giemsa, plus rarement immunohistochimie - Test rapide à l'uréase : résultat immédiat (< 1h) associé à l'histologie - Culture avec antibiogramme : en centre spécialisé si échec d'éradication
			Tests non endoscopiques	- Test respiratoire à l'urée marquée au ¹³C = contrôle de l'éradication : à jeun (6h), arrêt des anti-acide = 1 semaines, IPP = 2 semaines et antibiotiques = 4 semaines - Sérologie <i>H. pylori</i> = en cas de situation diminuant la sensibilité des techniques sur biopsies : IPP ou antibiothérapie récente, hémorragie, atrophie gastrique - Détection antigénique dans les selles : rarement utilisée
	DD	- Clinique : ADK/lymphome gastrique, douleur pancréatique ou biliaire, insuffisance coronarienne, péricardite, ischémie mésentérique, douleur vertébrale projetée, dyspepsie non ulcéreuse - Endoscopique : ADK ulcéroforme, ulcère gastrique lymphomateux, maladie de Crohn gastrique ou duodénale		
Ulcère de stress		= Patient en réanimation avec défaillance viscérale : ulcérations multiples nécrotico-hémorragiques - FdR : intubation et ventilation mécanique > 48h, troubles de coagulation, brûlures étendues, TC		

Complications	Hémorragie digestive		= Fréquente, parfois inaugurale : 30-40% des hémorragies digestives hautes, 10% de mortalité - FdR : prise d'AINS, antiagrégant ou anticoagulant, atcd d'ulcère (complicé ou non), âge > 65 ans - Manifestation : anémie ferriprive, hématomèse et/ou méléna , voire choc hémorragique - Endoscopie après correction du choc hémorragique : affirme l'origine ulcéreuse ± hémostase endoscopique si saignement persistant en jet/en nappe, vaisseau visible ou caillot adhérent	
	Classification de Forrest		- IA : jet artériel - IIA : vaisseau visible - IIC : tâche noire - IB : suintement - IIB : caillot adhérent - III : pas de signe	
	Perforation ulcéreuse		= Favorisée par la prise d'AINS, masquée par la prise de corticoïdes - Perforation en péritoine libre : douleur épigastrique intense en coup de poignard de début brutal, nausées et vomissements, signes de choc, sans fièvre, disparition de la matité pré-hépatique (inconstante), contracture épigastrique puis généralisée, cul-de-sac de Douglas douloureux au TR → pneumopéritoine avec réaction inflammatoire antro-pyloro-bulbaire au TDM → Contre-indication absolue à l'endoscopie - Au contact d'un organe (pancréas ++) = ulcère perforé-bouché : régression de la douleur initiale, sans pneumopéritoine, évolution possible vers la formation d'un abcès	
	Sténose ulcéreuse		= Complication rare des ulcères bulbaires et pré-pyloriques à composante fibreuse et inflammatoire - Vomissements post-prandiaux tardifs : risque de déshydratation et de troubles ioniques - A l'examen : clapotage gastrique à jeun (stase gastrique) et ondes péristaltiques - Endoscopie + biopsies (après évacuation de la stase gastrique par aspiration) ± transit baryté	
TTT des ulcères non compliqués	Transformation cancéreuse		- Ulcère gastrique : - Risque faible de cancérisation sur les berges d'un ulcère bénin - Risque de cancérisation à distance due à la gastrite à <i>H. pylori</i> - Ulcère duodénal : aucun risque de transformation cancéreuse	
			= Réduit le risque de récurrence à 5% à 1 an (contre 50 à 80% sans éradication)	
	Antibiothérapie séquentiel		- IPP à double dose (pleine dose x 2/jours) pendant 10 jours - Antibiotique : amoxicilline de J1 à J5 puis clarythromycine + métronidazole de J6 à J10 → Traitement non séquentiel (antibiotiques + IPP pendant 14 jours) recommandé	
	Quadrithérapie bismuthée		- IPP à double dose : oméprazole 20 mg 2 fois/jour - Métronidazole + tétracycline + sous-citrate de bismuth x 3 gélules x 4/j pendant 10 jours	
	Suites	IPP à dose pleine pendant 6 semaines	- Ulcère gastrique : systématique - Ulcère duodénal : si poursuite d'un AINS, anticoagulant ou antiagrégant, persistance de douleurs épigastriques ou ulcère initialement compliqué	
		IPP à demi-dose en continu	- Ulcère gastrique (complicé ou non) si poursuite d'un traitement par AINS - Ulcère gastrique compliqué si poursuite d'un traitement par aspirine	
	Suivi		= Contrôle systématique 4 semaines après la fin du traitement IPP et antibiotiques : 20% d'échec - Méthode : - Ulcère duodénal : test respiratoire à l'urée marquée - Ulcère gastrique : endoscopie gastrique avec biopsies antrales et fundiques + biopsie de la zone cicatricielle (possible cicatrisation d'un cancer ulcéro-forme) - En cas d'éradication réussie : aucune indication d'IPP au long cours, risque de réinfection très faible - En cas d'échec : switch de la stratégie thérapeutique - En cas de 2 nd échec : endoscopie avec culture pour antibiogramme et antibiothérapie adaptée - En cas d'échec après plusieurs lignes de traitement : IPP à dose préventive au long cours si ulcère duodénal ou ulcère gastrique compliqué	
	Ulcère aux AINS		- TTT curatif : IPP pendant 4 semaines si duodénal ou 8 semaines si gastrique ± maintien des AINS - Contrôle endoscopique de cicatrisation systématique en cas d'ulcère gastrique - TTT préventif : IPP pendant la durée d'un traitement par AINS si âge > 65 ans, antécédents d'ulcère gastro-duodénal et/ou association d'AINS avec un antiagrégant, des corticoïdes ou un anticoagulant	
	Ulcère non lié à <i>H. pylori</i> ou aux AINS		- Eliminer : syndrome de Zollinger-Ellison (si duodénal), maladie de Crohn, lymphome ou cancer gastrique - Ulcère duodénal : IPP pendant 4 semaines puis discuter un traitement par IPP au long cours - Ulcère gastrique : IPP pendant 4 à 8 semaines suivi d'un contrôle endoscopique avec biopsies, répété en cas d'absence de cicatrisation, voire discuter la chirurgie si nouvel échec	
	TTT chirurgical	Ulcère gastrique	= Gastrectomie partielle ou antrectomie ± vagotomie - Indication : non cicatrisé après 3-4 mois de traitement ou avec dysplasie sévère	
		Ulcère duodénal	= Vagotomie hyper-sélective ou vagotomie tronculaire avec antrectomie - Indication exceptionnelle : rechutes fréquentes sous IPP, mauvaise observance → Eliminer formellement un syndrome de Zollinger-Ellison avant la chirurgie	

TTT d'ulcères compliqués	Ulcère perforé	→ Hospitalisation en urgence en réanimation et conditionnement + SNG en aspiration - Antibiothérapie probabiliste large spectre (active sur les aérobie et anaérobies digestifs) - IPP forte dose : bolus de 80 mg IVL puis 8 mg/h	
		Traitement médical	= Méthode de Taylor : mise à jeun ± nutrition parentérale - Possible si : - Diagnostic certain - Terrain favorable - Survenu à jeun (> 6h) - Sans fièvre, choc ou hémorragie - Traitement débuté dans les < 6h → TDM abdominal possible pour préciser l'indication
		Traitement chirurgical	- Suture de l'ulcère ± exérèse avec examen histologique et bactériologique - Nettoyage péritonéal
	Sténose ulcéreuse pyloro-bulbaire	- TTT médical : évacuation de la stase gastrique par SNG , perfusion et IPP par voie IV - TTT endoscopique si échec : dilatation de la sténose au ballonnet + biopsies de la zone sténosée - TTT chirurgical si échec : antrectomie-vagotomie avec anastomose gastro-jéjunale	

GASTRITE			
Gastrite = définition histologique : atteinte inflammatoire aiguë ou chronique de la muqueuse de l'estomac - Examen des biopsies antrales et fundiques : nature et degré des lésions, topographie → classification de Sidney - Sans corrélation entre l'atteinte histologique et la symptomatologie ou l'aspect endoscopique			
GASTRITE CHRONIQUE	- Gastrite chronique : atrophiante (à risque de cancer) ou non atrophiante		
	Gastrite atrophiante	Gastrite chronique à <i>Helicobacter pylori</i> (Type B)	= Très fréquente : 20 à 50% de la population adulte en France - Sujet hyper-sécréteur = gastrite antrale : risque d'ulcère duodénal - Sujet hypo-sécréteur = pangastrite avec atrophie multifocale : risque d'ulcère gastrique et d'adénocarcinome gastrique - Plus rarement : évolution vers un lymphome gastrique du MALT - En l'absence de lésion : asymptomatique ou troubles dyspeptiques - Diagnostic : biopsie de l'antrum et du corps à l'endoscopie
		Gastrite chronique auto-immune (Type A)	= Gastrite limitée au corps, caractérisée par un infiltrat lympho-plasmocytaire et une atrophie progressive des glandes du fundus - MAI : - Plus fréquente chez la femme de 50 ans - Contexte d'auto-immunité : diabète 1, thyroïdite, vitiligo... - Ac sériques anti-cellules pariétales et anti-facteur intrinsèque
	Gastrite non atrophiante		- Carence en FI → malabsorption de vitamine B12 : anémie macrocytaire arégénérative , glossite, signes neurologiques (sclérose combinée de la moelle) - Risque d' ADK et de tumeur endocrine du corps gastrique : surveillance endoscopique systématique tous les 3 ans (si < 70 ans et bon état général)
		Gastrite chronique lymphocytaire	= Présence anormalement élevée de lymphocytes T dans l'épithélium de surface et des cryptes avec infiltrat inflammatoire : généralement asymptomatique - Le plus souvent idiopathique , ou associée avec une maladie coeliaque
		Gastrite granulomateuse	= Présence dans le chorion de granulomes épithélioïdes et géo-giganto-cellulaires - Cause : maladie de Crohn, sarcoïdose, tuberculose, syphilis, parasitaire (anisakiase, cryptosporidiose), mycotique (histoplasmoses, candidose), corps étranger, idiopathique
		Gastrite à éosinophiles	= Infiltration à PNE de la paroi gastrique : liée à une allergie alimentaire , une parasitose (anisakiase) ou associée à une entérite à éosinophile
GASTRITE AIGUË	Gastrite aiguë à <i>Helicobacter pylori</i>		= Suit la contamination orale : asymptomatique , ou douleur épigastrique, nausées, vomissements - Endoscopie = lésions prédominantes de l'antrum : muqueuse érythémateuse, oedématisée, nodulaire avec des lésions pétiécales, érosives ou ulcéro-nécrotiques - Diagnostic par biopsie : présence de <i>Helicobacter pylori</i> avec inflammation de la muqueuse à PNN - Evolution : régression en cas d'éradication ou évolution vers la chronicité si non traité
	Gastrite phlegmoneuse		= Exceptionnelle : infection bactérienne sévère dans l'épaisseur de la paroi gastrique, généralement chez un sujet immunodéprimé
	Gastrite virale		= Gastrite à CMV ou à HSV : sujet immunodéprimé (exceptionnel chez l'immunocompétent)

GASTROPATHIE

= Affection diffuse de la muqueuse gastrique sans infiltrat inflammatoire : diagnostic différentiel des gastrites

Classification	Gastropathie aux AINS	- Endoscopie caractéristique = lésions fréquentes, souvent multiples, prédominante dans l'estomac : pétéchies, érosions, ulcérations, ulcère gastro-duodénal	
	Gastropathie chimique	= Réactionnelle : - Prise excessive d'alcool - Reflux biliaire duodéno-gastrique (après gastrectomie)	
	Gastropathie congestive	- Gastropathie d'hypertension portale : aspect en mosaïque de la muqueuse fundique, pétéchies, varices cardio-tubérositaires - Syndrome d'ectasie vasculaire antrale : macules rouges convergeant vers le pylore, avec aspect « d'estomac pastèque », associé dans 1/3 des cas à une cirrhose	
	Gastropathie hypertrophique	Maladie de Ménétrier	= Pathogénie inconnue : tableau de gastropathie exsudative avec syndrome oedémateux par fuite protéique - Epaissement majeur de la muqueuse fundique : hyperplasie des cryptes - Endoscopie : plis fundiques géants, cérébriforme - Risque de transformation adéno-carcinomateuse - TTT : - Anti-sécrétoire (IPP) au long cours - Gastrectomie en cas d'échec dans les formes sévères
		Gastropathie du syndrome de Zollinger-Ellison	- Aspect hypertrophique des plis du fundus lié à l' hyperplasie des glandes fundiques sous l'effet trophique de la gastrine
	Gastropathie radique	= Après irradiation > 45 Gy - Complication aiguë : œdème avec érosion hémorragique , d'évolution favorable - Complication chronique après > 6 mois : ulcération, télangiectasie souvent hémorragique → Biopsies multiples : éliminer une récurrence tumorale	

Indications de recherche <i>Helicobacter pylori</i>	Ulcère ou situation à risque	- Ulcère gastroduodénal - Dyspepsie non ulcéreuse (gastroscopie normale) - Avant de débuter un traitement par AINS
	Prévention du cancer gastrique	- Antécédent personnel ou familial au 1 ^{er} degré de cancer gastrique - Syndrome de Lynch - Lymphome du MALT gastrique - Lésion gastrique pré-néoplasique : atrophie, métaplasie, dysplasie - Traitement au long cours par IPP > 6 mois - Avant chirurgie pour by-pass gastrique (endoscopie impossible après)
	Autre	- Lors de toute endoscopie gastrique - Carence en fer inexpliquée - Carence en vitamine B12 - Purpura thrombopénique immunologique - Souhait du patient